

Fecha Última Actualización: 16-09-2022 3:05:19

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Leonor Merino Carrasco
Edad : 82a 2m 14d
Dirección : Lucreci Borgia 2348

Rut : 5.612.118-8
Fecha Nacto: 02/07/1940
Comuna : La Florida

N° Archivo : 1220129
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5201 9527

N° Epicrisis
317616

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 17/07/2022 18:27
Fecha Egreso : 16/09/2022 03:09

Días Estadía: 61

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Caída de escaleras

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Leonor Merino Carrasco
Edad: 82
Rut: 5612118-8
FI CASR: 17/07/22
FI RECU: 19/07/22
FI UPC: 19/07/22

ANTECEDENTES

- 1) Mórbidos: ICC FE desconocida, DM2 NIR, RVM mecánico en TACO
- 2) Quirúrgicos: Recambio valvula mitral (mecánica)
- 3) Fármacos: TACO
- 5) Alergias: desconocidas
- 6) Hábitos: desconocidos
- 8) Inmunizaciones: desconocidas

Paciente trasladada de HLF traída por SAMU. Sufre caída de escalera (8 escalones), evolucionando con compromiso de conciencia y recuperación progresiva hasta basal.

Se toman imágenes en HLF:

- TC cerebro: hematoma subdural frontal derecho con pequeño foco hemorrágico en el espacio subdural parietal izquierdo, con contenido hemático del asta posterior del ventrículo d°. infarto lacunar talámico d°. hematoma epicraneal fronto parietal bilateral de predominio a d°.
- TC cervical: fx de los arcos posteriores de c1. fx de base de cuerpo vertebral de c2 en base de a. odontoides. fx de la a. espinosa de c7. fx no desplazada de la a. transversa i° c7.
- TC tórax: fx de los arcos costales posteriores de las primeras costillas bilaterales. fx no desplazada del arco posterior de la 2 costilla izquierda. atelectasias subsegmentarias

Paciente ingresa en GCS 15, cooperadora, evaluada en UEA x Neurocx al ingreso (sin indicación neuroquirúrgica) con indicación de hospitalización y vigilancia neurológica por TEC complicado. Evaluada por equipo TMT quienes refieren manejo ortopédico con collar cervical tipo Filadelfia e indican realizar RM columna cervical para descartar compromiso banda tensión

Fecha Epicrisis : 16/09/2022 03:05

Página 1 de 3

C7.

Evoluciona en UEA 18/07/22 12H00 con deterioro de conciencia a GCS 12, evaluado con neurocirugía con nuevo TC, control INR 4. Dado quiebre clínico, se decide reversión anticoagulación con octaplex y se desestima intervención Ncx. Se decide retirar collar cervical por indicación ncx, para favorecer drenaje de edema y dejar con almohadas para inmovilización cervical. Paciente evoluciona con deterioro progresivo de conciencia hasta GSC 8, TAC con aumento de hidrocefalia, evaluado nuevamente por neurocirugía, se conversó con familia y se decidió instalación de DVE realizada 19/07/22, sin incidentes, TC cerebro de control muestra adecuada instalación de DVE. En recuperación se mantiene con DVA para mantener PAM >70 y se disminuye sedación dado resultados de TAC para eventual weaning.

Se traslada a UCI para continuar manejo

Microbiología

- LCR (19/07): ligeramente turbio, prot: 2.1, gluc: 93, sin células, Gram: sin bacterias, cultivo pendiente

- PCR COVID (17/07): (-)

EVOLUCIÓN EN UCI

HEMODINÁMICO/CARDIOVASCULAR: Con requerimiento intermitente de DVA en contexto de shock séptico.

Durante estadía hospitalaria con diuresis adecuada.

Politransfundida. Cursa con anemia leve, estacionaria, sin evidencia de sangrado.

Se reinició anticoagulación (por RVM mitral) con dalterparina inicialmente por falla renal, luego con Enoxaparina. Se inicia manejo de fibrilación auricular para control de FC con Amiodarona.

VENTILATORIO: Intubada el 18/07 por compromiso de conciencia.

Weaning prolongado por compromiso de conciencia por lo que se realizó el 10/08 TQT quirúrgica.

Crítica crónica, no se logra destete de VMI por compromiso hemodinámico intermitente, fuele deteriorado, múltiples intercurencias infecciosas.

Además secundario a instalación de CVC presentó Neumotórax izquierdo, requirió instalación de pleurostomía aspirativa que se logra retirar el 17/08.

INFECCIOSO: El 27/07 presentó fiebre y alza de parámetros inflamatorios, se pancultivó y se inició esquema Meropenem/Vancomicina.

Cursó con Shock séptico, foco no precisado, rescatando solamente HC y CVC Lactobacillus sp, completó tratamiento.

Nuevo HIT infeccioso, se inició Tigeciclina por NAVM por ACBA, evaluada por Infectología se ajustó terapia a Colistin 17/08.

Con parámetros inflamatorios estacionarios, evoluciona febril y se pancultiva el 22/08, se rescata CAET (+) a PSAE y control TAC sin colecciones, conversado con Infectología se define ajuste antibiótico a Ceftazidima 24/08, con buena evolución, completa tratamiento.

El 06/09 febril persistente, se pancultivó y se inició esquema Ceftazidima/Amikacina. Del estudio SO inflamatorio, abundantes levaduras, UC polimicrobiano, CAET PSAE + ACBA, HC 1 y 2 PAE multisensible.

Se ajustó esquema antibiótico a Colistin.

El 14/08 estando con Colistin cursa febril, se describe cambio de CUP con salida de pus, se toma UC.

Evoluciona con deterioro clínico, parámetros inflamatorios altos estacionarios.

NEUROQUIRÚRGICO: TEC complicado, hidrocefalia que requirió instalación de DVE 19/07, tras prueba de cierre y control TAC, el 09/08 se retira DVE.

Paciente se mantiene vigil, pero sin conexión con el medio, no moviliza extremidades, evaluada el 12/08 por Neurología, con TAC 31/07 infarto limitrofe ACM-ACP izquierdo subagudo con transformación hemorrágica petequeal no confluyente, con recuperación de nivel de conciencia, sin embargo muy limitada en cuanto a lo funcional, se sugiere mantener terapia anticoagulante, por sus antecedentes, Y neurorehabilitación, el 16/08 se realiza EEG sin actividad epileptiforme, se mantiene con Fenitoína, último TAC cerebro 19/08.

Evolucionó 23/08 con rash y alteración de pruebas hepáticas de forma limitada, por lo que se sospechó RAM por Fenitoína, sin eosinofilia.

Con compromiso de conciencia multifactorial (sepsis, hipoxemia, hipotensión, Fentanilo).

TRAUMATOLOGÍA: Fractura cervical C1 y C2 en manejo ortopédico, 6 semanas con collar Filadelfia, estaba pendiente realizar RM cervical para descartar compromiso banda tensión C7. Con fractura en mano por lo que se realiza Rx, estaba pendiente resolución por TMT en mejores condiciones.

Por deterioro de conciencia se define retiro de collar cervical.

VASCULAR: Por ausencia de pulso de EII se solicita AngioTAC de EII 07/08: sin representación angiográfica arteria tibial anterior en el tercio medio - distal, de la arteria pedia ni de la arteria peronea izquierdas. Se interpreta como isquemia de pie izquierdo, evaluado por Cx vascular, con plan de posición arterial y anticoagulación.

Fecha Última Actualización: 16-09-2022 3:05:19

Página 3 de 3

Renal: sin falla renal, sin conflicto hidroelectrolítico, evoluciona con tendencia a oliguria.

Nutricional: Inició Nutrición Enteral con Diben bien tolerado. Mantuvo deposiciones de forma regular.

Paciente evoluciona con extrema grave en contexto de nuevo hit infeccioso, según lo relatado previamente, febril y con ascenso de parámetros inflamatorios aun estando con Colisitin.

Inicia requerimiento de DVA.

Conversado con Jefatura, se decide manejo proporcional. Se da aviso a familiares. Se favorece visita.

Diagnóstico de Egreso

OTROS TRAUMATISMOS DE LA CABEZA, ESPECIFICADOS - 1.NAVM por PSAE bacteriémica/ACBA en tratamiento

2.Obs ITU

3.NAVM ACBA/PSAE tratada

4.Shock séptico resuelto, foco no precisado

5.Politraumatismo 17/07

TEC complicado

TC ingreso: HSD Fontal derecho con pequeño foco hemorrágico en el espacio subdural parietal izquierdo, con contenido hemático del asta posterior del ventrículo d°. Infarto lacunar talámico d°. Hematoma epicraneal fronto parietal bilateral de predominio a d°.

iHidrocefalia- Instalación DVE 19/07 retirado 09/08

Fracturas cervicales manejo ortopédico

Fx de los arcos posteriores de C1

Fx de base de cuerpo vertebral de C2 en base de A. odontoides.

Fx de la A. espinosa de C7.

Fx no desplazada de la A. transversa i° C7

Fracturas costales manejo conservador

Fx de los arcos costales posteriores de las primeras costillas bilaterales.

iFx no desplazada del arco posterior de la 2 costilla izquierda

Fractura distal radio izquierdo

6.ACV isquémico, infarto subagudo ACM-ACP izquierda.

7.Neumotórax izquierdo-Ple

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece el 16/09/2022 a las 02:00 am.

Plan Post Alta

Se da aviso a familiares, se realiza certificado de defunción.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Absoluto

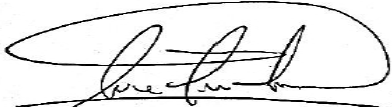
Régimen Alimentario : Diben 80 Cc/H

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Mario Alex Contreras Torrez
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 16/09/2022 03:05

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:19

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar